# SDD 209 Sujet n°1

## Spécialité : Endocrinologie-diabétologie

Date : 24/10/2023
Auteur : SAMANNI Léa (DES Endocrinologie-diabétologie-nutrition, ECN 2023)
Relecteur(s) : VILLARD Sébastien (DES de Médecine interne, ECN 2023), VILLETTE Ombeline (DES Endocrinologie-diabétologie-nutrition, ECN 2022)

| | |
|---|---|
| Domaine d'apprentissage principal | Entretien/interrogatoire |
| Domaine d'apprentissage secondaire | Éducation/prévention |
| Item en lien avec la station | ITEM 240 - Hypoglycémies |
| Situations de départ en lien avec la station | SDD 209 - Hypoglycémies<br>SDD 50 - Malaises et pertes de connaissance |
| Matériel nécessaire à la station | 1 bureau, 2 chaises<br>1 ordonnance avec les traitements habituels du patient à remettre au candidat |
| Contexte de la station | Patient diabétique de type 2 de 61 ans qui vient en consultation pour des malaises à répétition depuis 1 mois |

**TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales**
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

| ECOS TACFA |
| --- |
| INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E |

**Contexte :**
Vous êtes médecin généraliste en ville.
Vous recevez au cabinet le patient Monsieur MOUTOU, âgé de 61 ans, qui présente depuis 3 mois des malaises à répétition.
Il présente comme antécédents un diabète de type 2 depuis 10 ans et une dyslipidémie.

Ses traitements sont :
- Atorvastatine TAHOR ® 20 mg/jour
- Metformine GLUCOPHAGE ® 2000 mg /jour
- Sitagliptine JANUVIA ® 50 mg/jour
- Gliclazide DIAMICRON ® 60 mg/jour (depuis 2 mois)

**Consignes :**
Vous devez en 7 minutes :
- Faire l'interrogatoire du patient et préciser les caractéristiques de ses malaises.
- Expliquer au patient la cause la plus probable de ses "malaises" et l'attitude thérapeutique qui en découle.
- Proposer une modification de son ordonnance.

Vous ne devez pas :
- Réaliser l'examen clinique du patient
- Orienter le patient vers un spécialiste
- Rédiger l'ordonnance modifiée

Attention : Vous avez 7 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

**TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales**
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

| ECOS TACFA |
|---|
| GRILLE D'ÉVALUATION |

**Consigne(s) à l'évaluateur :**

| Interrogatoire | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Recherche les antécédents cardiovasculaires personnels OU familiaux | 1 pt | ☐ |
| 2. | L'étudiant questionne le patient sur la fréquence de survenue des malaises. | 1 pt | ☐ |
| 3. | L'étudiant questionne sur l'existence d'un horaire particulier de survenue des malaises Surviennent-ils plutôt : à jeûn, en post-prandial, la nuit… | 1 pt | ☐ |
| 4. | L'étudiant questionne sur l'éventuel caractère positionnel de ces malaises<br>*Position : débout/couché/passage en position debout*<br>*-> (éliminer une Hypotension orthostatique)* | 1 pt | ☐ |
| 5. | L'étudiant questionne sur le caractère lié ou non à l'effort de ces malaises. | 1 pt | ☐ |
| 6. | L'étudiant questionne sur :<br>- les circonstances de survenue de ces malaises ET la présence de prodromes<br>*Exemple de circonstances : émotion, chaleur, vue du sang, foule, rasage*<br>*Exemple de prodromes : nausées, sensation de faiblesse, sueurs, baillements…* | 1 pt | ☐ |
| 7. | L'étudiant recherche une perte de connaissance associée ou non à ces malaises. | 1 pt | ☐ |
| 8. | L'étudiant questionne sur l'amélioration de l'état du patient après resucrage.<br><br>*Exemple de question attendue : "Est ce que vous avez déjà essayé de manger ou de boire une boisson sucrée lors de ces épisodes ?".* | 1 pt | ☐ |
| 9. | L'étudiant demande si un contrôle glycémique a déjà été fait au cours d'un épisode de malaise (par le patient ou par ses proches)<br><br>*Exemple de question attendue : "Avez-vous déjà contrôlé (ou fait contrôler par un proche) votre glycémie au cours d'un épisode de malaise ?" !* | 1 pt | ☐ |

**TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales**
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. | Rechercher les symptômes adrénergiques (*au moins 3 pour avoir le point*) : palpitations, tachycardie, sueurs, tremblements, pâleur, anxiété, sensation de chaleur, nausée. | 1pt | ☐ |
| 11. | Recherche les symptômes de neuroglucopénie (au moins 3 pour avoir le point) : difficulté de concentration, fatigue, troubles de l'élocution, troubles du comportement, troubles moteurs, troubles sensitifs, tremblements, troubles visuels, convulsions, confusion. | 1pt | ☐ |
| 12. | Préciser la fréquence de mesure des glycémies. | 1pt | ☐ |
| 13. | Demander au patient la valeur de sa dernière hémoglobine glyquée. | 1pt | ☐ |
| 14. | L'étudiant identifie le médicament responsable (le Gliclazide = sulfamide hypoglycémiant) et proposer sa suspension/son arrêt et explique simplement ce choix au patient :<br><br>*Exemple de réponse attendue : "les malaises sont probablement des hypoglycémies secondaires à la prise de Gliclazide".* | 1pt | ☐ |
| 15. | L'étudiant répond correctement à la question du patient quant à l'absence de risque d'hypoglycémie sous Metformine et Gliptine. *Rappel : patient chauffeur de bus !*<br><br>*Réponse attendue : "Il n'existe pas de risque d'hypoglycémie sous Metformine et Gliptine et la conduite n'est alors pas contre-indiquée".* | 1pt | ☐ |
| **Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)** | | | |

**2. APTITUDE À QUESTIONNER**

| Performance Insuffisante<br><br>0 point | Performance Limite<br><br>0,25 point | Performance Satisfaisante<br><br>0,5 point | Performance Très Satisfaisante<br><br>0,75 point | Performance Remarquable<br><br>1 point |
|---|---|---|---|---|
| Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs<br><br>Utilise le jargon médical | Pose des questions qui s'éloignent des objectifs<br><br>Utilise quelques fois un jargon médical sans explication | Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels<br><br>Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications | Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures<br><br>Utilise le langage approprié | Pose les questions avec assurance et savoir-faire |

**TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales**
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

## 1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair

| Performance Insuffisante<br><br>0 point | Performance Limite<br><br>0,25 point | Performance Satisfaisante<br><br>0,5 point | Performance Très Satisfaisante<br><br>0,75 point | Performance Remarquable<br><br>1 point |
|---|---|---|---|---|
| Interrompt le patient /pair de façon inappropriée<br><br>Ignore les réponses du patient/collègue | Se montre impatient | Est attentif aux réponses du patient/pair | Est attentif aux réponses du patient/pair<br><br>Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs. | Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations. |

## 8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES

| Performance Insuffisante<br><br>0 point | Performance Limite<br><br>0,25 point | Performance Satisfaisante<br><br>0,5 point | Performance Très Satisfaisante<br><br>0,75 point | Performance Remarquable<br><br>1 point |
|---|---|---|---|---|
| N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème | Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier | Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement | Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement | Agit avec assurance et sans erreur |

## 12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

| Performance Insuffisante<br><br>0 point | Performance Limite<br><br>0,25 point | Performance Satisfaisante<br><br>0,5 point | Performance Très Satisfaisante<br><br>0,75 point | Performance Remarquable<br><br>1 point |
|---|---|---|---|---|
| Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique | Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche | Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche. | Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche. | Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise). |

| TOTAL (/19 points) | X points |
|---|---|

**TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales**
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

**Éléments de rétroaction :**

- *AVANT TOUT : faire préciser la signification du mot "malaise" par le patient d'emblée pour éviter de partir sur des étiologies cardiologiques/vasculaires.*
- *Prendre le temps de bien lire l'ordonnance ! On aide le candidat en la lui fournissant dès le début de la station et on précise l'ajout récent d'un médicament.*

**TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales**
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

| ECOS TACFA |
| --- |
| SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ |

**Consignes génériques pour le patient :**

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

**Rappel du scénario du candidat** :

Monsieur MOUTOU, âgé de 61 ans, consulte au cabinet devant des épisodes de malaise depuis environ 3 mois.

**Plan de la station ECOS** :

Un bureau avec 2 chaises. L'acteur.trice s'asseoit en face des candidats.es

**Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :**

"Voilà docteur, je viens parce que je fais des malaises depuis 3 mois.
J'aimerais bien que vous trouviez pourquoi, parce que ça m'embête quand même beaucoup.
Je vous donne la liste de mes traitements, c'est ma dernière ordonnance prescrite par mon endocrinologue, qui date de 6 mois environ, il m'a rajouté un médicament pour le diabète".

**Identité du patient :**

Monsieur MOUTOU
61 ans
1m80, 95 kg (IMC 29,3)

**Mode de vie :**

Marié, deux enfants.
Absence d'intoxication alcoolo-tabagique.
Absence d'allergie.
Chauffeur de bus à Marseille.

**TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales**
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Il s'est remis au sport récemment, va courir 2 fois par semaine pour essayer de perdre du poids, mais gêné par ces “malaises” !

**Comportement global :**

Patient inquiet de la survenue de ces malaises. Calme et à l’écoute.
Donne une bonne description de ses malaises (signes adrénergiques + signes de neuroglucopénie).

Patient d’accord et soulagé pour changer de traitement.

**Antécédents personnels :**

Diabète de type 2 depuis 10 ans
Dyslipidémie

**Antécédents familiaux :**

Diabète de type 2 chez le père
Cancer du sein chez la mère

**Médicaments :**

- Atorvastatine TAHOR ® 20 mg/jour
- Metformine GLUCOPHAGE ® 2000 mg /jour
- Sitagliptine JANUVIA ® 50 mg/jour
- Gliclazide DIAMICRON ® 60 mg/jour

**Symptômes positifs :**

- Si l’étudiant(e) demande quels sont les ATCDS cardiovasculaires personnels ou familiaux : répondre “Aucun”.

- Concernant les caractéristiques des malaises : ne répondre qu’à la question posée par l’étudiant(e) :
  - Surviennent depuis 3 mois environ
  - Surviennent parfois “le soir avant le dîner quand on mange tard ma femme et moi !”
  - Pas de position particulière de survenue
  - Surviennent 2 à 3 fois par semaine, après les séances de footing !
  - Survenue donc en lien avec des efforts importants ou une période de jeûne
  - Pas de perte de connaissance associée. Mais grande “fatigue”

**TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales**
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l’accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

- Si l'étudiant demande si un contrôle glycémique a été effectué au cours de ces épisodes de malaise : "Et non docteur je n'ai jamais contrôlé ma glycémie à ces moments là"
- Si l'étudiant demande si les malaises sont améliorés par le resucrage : "Ah ça oui par contre : un petit verre de jus de fruit et ça allait beaucoup mieux"

- Présence de signes adrénergiques : palpitations, sueurs froides, nausées et grande fatigue.

- Présence de signes de neuroglucopénie : Paresthésie dans les membres, sensation de faiblesse des membres inférieurs. Difficultés de concentration.
"Quand ça m'arrive Docteur, je suis obligé de m'asseoir, j'ai les jambes qui tremblent, j'ai des fourmis partout. Et puis je n'arrive plus à réfléchir et me concentrer".

- Si l'étudiant demande si des contrôles glycémiques sont effectués habituellement ou au décours des épisodes de malaise : "Je ne contrôle pas vraiment mes glycémies docteur, l'endocrinologue a dit que ce n'était pas la peine avec mes médicaments actuels. Mais il m'a parlé du risque d'hypoglycémies avec le dernier traitement."

- Si l'étudiant(e) demande la valeur de la dernière hémoglobine glyquée : "Elle est à 5,5% docteur, sur ma prise de sang de la semaine dernière !".

- Si l'étudiant(e) propose de modifier l'ordonnance et arrêter la posologie du Gliclazide :
- Demander "Pourquoi Docteur?"
- **Demander également s'il persiste un risque sous Metformine et gliptine:"Est-ce qu'avec mes autres médicaments du diabète, je risque de refaire des malaises/hypoglycémies alors Docteur ? Parce que je suis chauffeur de bus quand même, il ne faudrait pas que cela m'arrive en conduisant !"**

**Constantes :**

FC : 75 bpm
TA : 134/86 mmHg
Dernière hémoglobine glyquée à 5,5% *(à donner à l'étudiant s'il la demande, en considérant bien sûr que le patient sait à quoi cela correspond).*

**TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales**
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

**Donnée complémentaire :**

| |
|---|
| Ordonnance d'il y a 6 mois, rédigée par l'endocrinologue de ville à remettre au candidat dès le début de la station. |

**Questions de relance :**

| |
|---|
| "Mais dites-moi Docteur, est ce que mes malaises pourraient être liés au dernier médicament que m'a prescrit l'endocrinologue ?"<br>*-> à proposer à la 6ème minute* |

**TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales**
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

| ECOS TACFA |
| --- |
| FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF) |

**Plan de la station ECOS :**

Patient placé en face de l'étudiant(e).
Un bureau/une table entre étudiant(e) et patient.
L'ordonnance sur la table.

**Matériel nécessaire à la station :**

- IPAD pour examinateur
- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur

**Documents présents dans la station :**

- Feuilles d'évaluation de papier de secours
- Ordonnance du patient

**TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales**
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)